REPORTE DE ESTADO DE PROYECTO (PSR)

10/01/2024 - 09/30/2025 - PSR-10479

SÍNTESIS DEL PROYECTO

Número de Operación
ME-T1485

Número de suboperación
ATN/ME-19230-ME

Nombre del proyecto
ANA Care: Improving Dependent Care for the Low-income Older Population through Technology

Lider de equipo
Tatiana Virviescas Mendoza

Agencia ejecutora
Paz Mental

Proposito
Profesionalizar el modelo de atención de adultos mayores y pacientes crónicos en casa que incluye la incorporación de tecnología en la formación de cuidadores y enel cuidado de pacientes en casa, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales y pers

Ciclo del Proyecto

Fecha de aprobación	Fecha de firma	Primera fecha de desembolso	Plazo de último desembolso
2022-05-02	2022-05-18	2022-07-05	2025-11-18

PUNTAJE PSR



- 0 - 1 Bandera roja
- 1 - 2 Bandera amarilla
- 2 - 4 Bandera verde

DRAFT

APRENDIZAJES

1. Implementación

1.1. Breve Resumen

1.1. Por favor, proporcione un breve resumen sobre el estado general de esta operación y los acontecimientos relevantes que han ocurrido durante la ejecución. Puede incluir las principales actividades realizadas, los resultados generales obtenidos, los cambios relevantes en el contexto y los próximos pasos contemplados. Si lo desea, esta sección puede organizarse por componentes.

Durante el periodo de ejecución, la operación avanzó de una fase de validación de valor hacia una fase de estructuración para escala nacional/regional. Por un lado, se consolidó la propuesta de Ana como plataforma tecnológica integral de salud y cuidado en casa para personas mayores y personas con dependencia, integrando tres componentes principales: (i) formación y certificación de cuidadores/as (Ana Ilumina / Ana Luz), (ii) acompañamiento a familias y coordinación del cuidado en el hogar (Ana Familiar / Ana Te Cuida), y (iii) soporte a prestadores de servicios de salud y aseguradoras para reducir costos evitables y liberar presión hospitalaria (Ana Salud / Ana Cuidado / Ana Gob). A nivel operativo, se realizaron ventas, negociaciones con acuerdos de trabajo con proveedores de salud en casa, actores públicos (por ejemplo, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Envejecimiento Digno/CDMX, Secretaría de Hacienda en México) y privados (aseguradoras, IPS domiciliarias y redes de cuidado), lo que permitió probar el modelo en contextos reales y recopilar evidencia de impacto clínico, operativo, económico y humano. Se avanzó también en conversaciones formales con gobiernos y pagadores sobre la incorporación del modelo de cuidado domiciliario y formación de cuidadores dentro de estrategias de bienestar, productividad y sostenibilidad financiera del sistema de salud. En paralelo, se fortaleció la capa tecnológica: se unificó en una sola plataforma los módulos de capacitación, seguimiento del cuidador, matching cuidador–familia y paneles de monitoreo para agencias/IPS, sentando las bases de una solución escalable, con potencial de interoperabilidad con sistemas públicos. El contexto externo cambió positivamente: la crisis de cuidados y envejecimiento activo entró en la agenda pública y empresarial, y la presión fiscal por hospitalizaciones evitables aumentó el apetito por soluciones de salud en casa. Los próximos pasos contemplados son: cerrar convenios marco de escala (con entidades públicas y aseguradoras), formalizar un modelo de contratación sostenible de mediano plazo que alinee incentivos entre gobierno y la empresa, y terminar de productivizar el módulo de inteligencia (la capa "AU / Ana AI") para automatizar monitoreo, adherencia y soporte emocional a cuidadores y familias, acelerando así la replicabilidad país por país. Durante la actualización de los indicadores se identificó que, en los componentes relacionados con: Porcentaje de alumnos que iniciaron un curso provenientes de zonas vulnerables, Porcentaje de alumnos con acreditación CONOCER provenientes de zonas vulnerables, Porcentaje de cuidadores que tomaron cursos en ANA y declaran haber mejorado sus condiciones laborales, y porcentaje de cuidadores que tomaron cursos en ANA y que declaran haber mejorado sus condiciones personales, los valores actuales resultan menores o iguales a los previamente reportados. Esta variación se explica porque, en las primeras mediciones, la base de datos era aún limitada, lo que generaba porcentajes relativamente altos. Conforme el proyecto avanzó, se integró un volumen más amplio y representativo de información, permitiendo recalcular los indicadores con mayor precisión. La disminución observada no representa un retroceso en el desempeño, sino un ajuste esperado derivado de la ampliación de la muestra utilizada para el cálculo. A pesar de estos ajustes, las metas establecidas para cada componente continúan cumpliéndose.

1.1.2. Describa los resultados logrados este año y su relación/contribución al objetivo de la TC. Si los resultados no se han completado según lo previsto, explique cómo afectará esto al progreso hacia la consecución del objetivo de la operación.

Este año se lograron resultados concretos en tres frentes que contribuyen directamente al objetivo de la TC (construir y validar un modelo sostenible y escalable de cuidado domiciliario profesionalizado en Latinoamérica): 1. Validación de valor para el sistema público y asegurador. Se desarrolló y se demostró por medio de un caso de uso claro para gobiernos y pagadores: formación acelerada y acompañamiento continuo de cuidadores domiciliarios reduce días de hospitalización evitables, mejora adherencia terapéutica y libera camas hospitalarias, generando ahorros presupuestales relevantes y alivio operativo. Esto permitió pasar de "innovation talk" a "contrato potencial". 2. Producto listo para replicar. Se evolucionó de una oferta fragmentada (cursos, acompañamiento emocional, referencias de cuidadores) a una plataforma integrada con módulos para cada actor: cuidadores, familias, agencias/IPS y gobierno/aseguradoras. Esto responde a la meta de la TC de contar con una solución tecnológica lista para escalar que pueda integrarse a estrategias nacionales de cuidado, no sólo a pilotos aislados. 3. Posicionamiento político e institucional. Se logró reconocimiento institucional y visibilidad internacional como actor líder en el tema de cuidados, envejecimiento digno y salud en casa, incluyendo invitaciones a foros de alto nivel y colaboración con multilaterales. Ese posicionamiento abre puertas para la etapa de escalamiento (regulatorio, normativo y de financiamiento), que forma parte explícita de la ruta planteada en la TC.

1.1.3. Historias del Proyecto Proporcione una historia relevante relacionada con esta TC, que puede incluir: una historia de éxito o de fracaso; una descripción de un evento que haya afectado o dirigido el proyecto; una descripción de los efectos positivos y/o negativos no previstos de la intervención; y, cuestiones para el diálogo político que hayan surgido y cómo.

Tipo de Historia	Texto de la Historia	Enlace (Si aplica)
Éxito	Empresas especializadas en cuidado y salud en casa en más de siete países de Latinoamérica han adoptado ANA como su plataforma tecnológica para gestionar y profesionalizar los servicios de atención domiciliaria. Más de tres empresas reportaron un crecimiento significativo en sus ingresos tras implementar la herramienta, al optimizar sus procesos operativos y fortalecer la calidad del servicio. A través de ANA, estas empresas lograron: - Reclutar y validar cuidadores con estándares clínicos y habilidades específicas. - Dar acompañamiento continuo a las familias y equipos de atención. - Documentar de forma estructurada la adherencia terapéutica y los signos de alarma, facilitando la comunicación con aseguradoras y familiares. Estos resultados consolidaron a ANA como una solución clave para mejorar la eficiencia operativa y la confianza del paciente en el servicio de cuidado en casa.	
Desafío	Durante el trabajo con prestadores privados de salud domiciliaria en Colombia, el equipo de ANA identificó una tensión recurrente: los proveedores buscaban personalizaciones y desarrollos a la medida, pero no estaban dispuestos a comprometerse contractualmente con pagos sostenidos en el tiempo si sus prioridades operativas cambiaban. Este patrón generó un riesgo financiero y de sostenibilidad tecnológica, por lo que el equipo decidió replantear el modelo de relación comercial. En lugar de ofrecer desarrollos personalizados que se perdían al finalizar el contrato, se creó un modelo de licenciamiento modular, en el cual las nuevas funcionalidades desarrolladas se integran al núcleo de la plataforma ANA, con: - Obligaciones mínimas de uso, - Cláusulas de salida que protegen la inversión tecnológica, y - Un esquema de crecimiento progresivo del producto. Este aprendizaje fue clave para la escalabilidad regional, ya que permitió mantener un producto más robusto, estandarizado y financieramente sostenible, evitando la fragmentación del sistema y fortaleciendo su valor a largo plazo.	

2. Escalabilidad

2.1.a Resultados PMV/Empresa/Solución/Proceso

2.1.1. a) En el último año calendario, ¿sus costos han sido cubiertos totalmente por las ventas o la financiación del programa? En caso afirmativo, seleccione cuánto de sus costos se están cubriendo para continuar brindando su solución/modelo/servicio.

[No]

2.1.2. En el último año calendario, ¿aumentó el número de clientes (individuos, hogares, empresas, organizaciones u otros) que utilizaron su solución/modelo/servicio? En caso afirmativo, ¿alcanzó o superó el número de clientes que esperaba alcanzar?

[Sí. y cumplimos la meta annual]

Nro. de Individuos o Hogares

2998

Nro. de Empresas y Organizaciones

27

Nro. de Individuos u Hogares

9853

Nro. de Empresas y Organizaciones

64

2.1.b Capacidad institucional para escalar

2.1.3. ¿Tiene su organización un plan de escalamiento que especifique los elementos clave necesarios para escalar la solución/modelo/servicio que se está financiando?

[Sí]

2.1.4. Indique la vía principal de escalamiento que el proyecto/iniciativa está siguiendo para alcanzar escala

[La solución se escalará a través de un esfuerzo conjunto (asociación) que involucre a mi empresa u organización y otras entidades]

2.1.5. ¿Está buscando activamente socios o interactuando con ellos para llevar su solución/modelo/servicio a escala?

[Sí]

2.1.5.1. En caso afirmativo, seleccione el grado de participación (si hay varios socios, seleccione todos los que correspondan)

[Acuerdo firmado/formal, Todavía buscando socio(s) pero sin haber llegado a ningún acuerdo, Acuerdo verbal/informal]

2.1.c Factores

2.1.6. ¿Cuáles de estos factores externos están facilitando el escalamiento de su solución/modelo/servicio? Seleccione solo aquellos que correspondan y lístelos en orden de prioridad.

[Los socios para el escalamiento ven valor en financiar/adoptar y/o adquirir la solución/modelo/servicio, La solución/modelo/servicio aborda una necesidad muy sentida por los clientes, Los clientes (individuos; hogares; empresas; organizaciones) están familiarizados y/o utilizan soluciones/modelos/servicios similares que podrían facilitar la adopción, La solución/modelo/servicio es comparativamente más efectivo y/o menos costoso que las alternativas existentes]

2.1.6.1 ¿Existe algún otro factor(es) externo que facilite el escalamiento de su solución/modelo/servicio? (Si no hay otro factor, dejar en blanco)

Sí. Hay factores externos que hoy están jugando a favor del escalamiento: * Prioridad política del envejecimiento y los cuidados. Varios gobiernos de la región ya declararon el cuidado domiciliario y el envejecimiento digno como prioridades públicas, y están buscando evidencia para justificar presupuesto. Esto crea ventana de política y recursos. * Presión fiscal y hospitalaria. Los sistemas de salud enfrentan saturación hospitalaria crónica y altos costos en estancias evitables. Esto abre apetito para modelos de “salud en casa” que liberen camas sin tener que construir más infraestructura física, lo que facilita que pagadores y ministerios de finanzas se sienten a negociar. * Interés de aseguradoras y prestadores privados. Aseguradoras de salud y redes de atención domiciliaria enfrentan la misma presión de costos y retención de clientes. Están buscando diferenciarse ofreciendo programas de cuidado continuo en el hogar, lo que genera demanda comercial inmediata para la solución. * Reconocimiento internacional. El posicionamiento de Ana como referente regional en la “economía del cuidado” y salud domiciliaria legitima la solución frente a actores públicos y multilaterales, lo que reduce barreras políticas iniciales al escalar.

2.1.7 ¿Cuáles de estos factores externos están dificultando el escalamiento de su solución/modelo/servicio? Seleccione solo aquellos que correspondan y lístelos en orden de prioridad.

[Los clientes (individuos; hogares; empresas; organizaciones) no están familiarizados y/o no utilizan soluciones/modelos/servicios similares que puedan facilitar la adopción]

2.1.7.1 ¿Existe algún otro factor(es) externo que dificulte el escalamiento de su solución/modelo/servicio? (Si no hay otro factor, dejar en blanco)

Sí. Existen barreras externas relevantes: * Ciclos presupuestarios y cambio de gobierno. Aunque hay voluntad, los procesos formales de contratación pública son lentos, tienen ventanas fiscales rígidas y pueden verse afectados por cambios de administración o prioridades políticas. Esto puede retrasar la firma de contratos a escala nacional aun cuando ya existe evidencia técnica. * Marco regulatorio difuso para el cuidado en casa. En muchos países el cuidado domiciliario vive en una “zona gris”: no está claramente normado si es salud, asistencia social o familia, lo que dificulta saber qué institución paga y bajo qué partida presupuestal. * Fragmentación del sistema de salud. En varios países conviven múltiples aseguradores / IPS / redes subnacionales y ninguna tiene el mandato (ni el presupuesto) para resolver todo el continuo de cuidados. Esto obliga a negociar caso por caso, elevando el costo comercial y ralentizando la expansión. * Capacidad de pago directa de las familias. La gran mayoría de cuidadoras y familias opera en la informalidad y con márgenes económicos muy bajos. Sin un tercero pagador (gobierno, aseguradora, programa corporativo), el ticket directo B2C es limitado, lo que hace más lenta la expansión puramente “retail”.

2.1.8 ¿Cuáles de estos factores internos están facilitando el escalamiento de su solución/modelo/servicio? Seleccione solo aquellos que correspondan y lístelos en orden de prioridad.

[El diseño de la solución/modelo/servicio es fácil de usar/intuitivo y práctico; lo que podría facilitar la adopción por parte de los clientes, La organización/empresa tiene capacidad para gestionar el proceso de escalamiento de la solución/modelo/servicios, Se han documentado y comunicado los resultados sobre la efectividad]

2.1.8.1 ¿Existe algún otro factor(es) interno que facilite el escalamiento de su solución/modelo/servicio? (Si no hay otro factor, dejar en blanco)

Sí. Hay fortalezas internas que hoy habilitan la escala: * Plataforma tecnológica modular lista para replicar. Ya no se es sólo “cursos para cuidadores”: se cuenta con módulos claros (formación, soporte emocional, matching cuidador–familia, monitoreo clínico básico, tableros de costos) que se pueden activar por cliente / país sin reconstruir desde cero. * Metodología probada y know-how operativo. Se cuenta con más de 10 años trabajando en cuidado y salud en casa en distintos países de América Latina, con una red amplia de socios, y con narrativa técnica y económica que ya habla el lenguaje de Hacienda / aseguradoras. Eso acorta la curva de adopción. * Alineación estratégica con pagadores. Internamente ya se hizo el ejercicio de traducir el impacto social ("cuidar a quien cuida") a métricas de negocio ("camas liberadas", "adherencia terapéutica", "reducción de costo por episodio"), lo que permite a Paz Mental con Ana Care sentarse con ministerios de finanzas, no sólo con áreas sociales. * Equipo con credibilidad pública y privada. El equipo consta de personas que pueden hablar tanto con ministerios y multilaterales como con direcciones médicas y comités de inversión de aseguradoras. Esta “puerta de entrada” mixta es un activo interno clave para escalar.

2.1.9 ¿Cuáles de estos factores internos están dificultando el escalamiento de su solución/modelo/servicio? Seleccione solo aquellos que correspondan y lístelos en orden de prioridad.

[Ninguno]

2.1.9.1 ¿Existe algún otro factor(es) interno que dificulte el escalamiento de su solución/modelo/servicio? (Si no hay otro factor, dejar en blanco)

Sí, y es importante registrarlo con honestidad: * Capacidad financiera / capital de trabajo. Para cerrar acuerdos grandes con gobierno o aseguradoras a veces es necesario desarrollar

integraciones, personalizar tableros o acompañar la operación inicial durante los primeros meses. Eso requiere caja previa antes de que entren los pagos formales. La falta de capital de trabajo suficiente puede frenar la velocidad de despliegue masivo, aunque la demanda esté ahí. * Recursos humanos senior en producto y operaciones multinacionales. Aún se está en la construcción de roles críticos (CTO, VP Product, responsables país en Brasil / Colombia / Argentina, responsable de relaciones gobierno). Sin ese “layer” ejecutivo completo, el equipo núcleo se estira demasiado entre diseño de producto, despliegue operativo y negociación estratégica. * Necesidad de balancear personalización vs. estandarización. Cada cliente grande (sobre todo IPS domiciliarias o aseguradoras) pide ajustes específicos. Si se brinda demasiada personalización, se arriesga el foco y velocidad de producto. Si no se da, algunas puertas se cierran. Encontrar ese equilibrio internamente, con procesos claros y contratos bien diseñados, sigue siendo un reto.

3. Despliegue de Tecnología

3.1. Factores de Nuevas Tecnologías

3.1.1. Si el proyecto/empresa/fondo hace uso de tecnologías o metodologías novedosas, ¿Qué factores han facilitado la implementación de la solución tecnológica propuesta inicialmente por el proyecto?

[Experiencia previa de la agencia ejecutora/cliente con la tecnología, Acceso a expertos en la materia por parte de la agencia ejecutora/cliente, Disponibilidad de proveedores/consultores, Disponibilidad de datos]

3.1.2. Si el proyecto/empresa/fondo hace uso de tecnologías o metodologías novedosas, ¿Qué factores han dificultado la implementación de la solución tecnológica propuesta inicialmente por el proyecto?

[Baja disponibilidad de datos]

4. Resultados de Desarrollo (Cuantitativo)

4.0 ¿Su proyecto/empresa/fondo ha contribuido a alguno de los siguientes indicadores durante este año calendario (Ene-Sept)?

[4.1. Número de empresas beneficiadas, 4.2. Empleos directos generados por el proyecto o financiamiento, 4.3. Hogares/Personas con condiciones de vida mejoradas]

4.1. Número de empresas beneficiadas

Total

64

Empresas propiedad/dirigidas por hombres

29

Empresas propiedad/dirigidas por mujeres

35

4.1.2. Señale qué indicador de la matriz de resultados se relaciona con su respuesta, o cómo ha calculado este número.

C2: Adquisición de usuarios y awareness, Empresas/coordinadores informales al cuidado de adultos mayores utilizando ANA

4.1.4. Por favor, seleccione cómo a través del proyecto se están beneficiando a estas empresas.

[Mejora de la productividad o el rendimiento empresarial (por ejemplo/mejora de las ventas/reducción de costes/mejora de la rentabilidad/rendimiento del capital/incremento de producción/productividad laboral)]

4.1.3. ¿Qué tipo de servicios recibieron las empresas?

[No Financiero]

4.2. Empleos directos generados o conectados por el proyectos o financiamiento

Total

9853

Empleos creados: número de hombres

1970

Empleos creados: número de mujeres

7882

4.2.2. Señale qué indicador de la matriz de resultados se relaciona con su respuesta, o cómo ha calculado este número.

C2: Adquisición de usuarios y awareness, Ofertas de empleos para cuidadores generadas

4.3. Número de hogares/Personas con condiciones de vida mejoradas

[Personas]

4.3.1. Total

1256

Hombres

427

Mujeres

829

4.3.3. Señale qué indicador de la matriz de resultados se relaciona con su respuesta, o cómo ha calculado este número.

Resultados finales_Familias que consiguen cuidadores a través de la plataforma ANA

4.3.4. Por favor, seleccione el tipo de beneficio.

[Mejor acceso a la salud]

4.5. Fuente de Datos

4.5.1. ¿Qué tipo de fuentes de verificación ha utilizado para informar los datos que proporcionó en esta sección? (Por favor, seleccione todas las respuestas válidas).

[Basado en experiencia personal, Información administrativa]

INDICADORES

Superado Logrado Pendiente En proceso Atrasado

C1: Creación e Implementación de Cursos

Peso: 46% **Calificación:** Satisfactorio

83%	17%

	Indicadores	Planeado	Logrado	Estado
I1	Cursos nuevos iniciados por alumnos dentro de la plataforma	3308 (2025-05-18)	7105 (2025-09-30)	
I2	Porcentaje de alumnos que hayan iniciado un curso, provenientes de zonas vulnerables	40 (2025-05-18)	52 (2022-09-30)	
I3	Cursos nuevos terminados por alumnos dentro de la plataforma	966 (2025-05-18)	3006 (2025-09-30)	
I4	Alumnos que reciben acreditación de CONOCER	90 (2025-05-18)	32 (2025-09-30)	
I5	Cursos creados	20 (2025-05-18)	187 (2023-06-30)	
I6	Porcentaje de alumnos con acreditación CONOCER provenientes de zonas vulnerables	10 (2025-05-18)	80 (2022-09-30)	

DRAFT

C2: Adquisición de usuarios y awareness

Peso: 36% **Calificación:** Altamente Satisfactorio

100%

	Indicadores	Planeado	Logrado	Estado
I1	Empresas o coordinadores dedicados al cuidado de adultos mayores a las que se les ofrecen los servicios de ANA	5 (2025-05-18)	88 (2025-09-30)	
I2	Plataforma de ANA funcional	0 (2025-05-18)	1 (2022-05-18)	
I3	Empresas o coordinadores informales dedicadas al cuidado de adultos mayores o pacientes crónicos utilizando ANA (acumulado)	3 (2025-05-18)	64 (2025-09-30)	
I4	Ofertas de empleos para cuidadores generadas	600 (2025-05-18)	9853 (2025-09-30)	

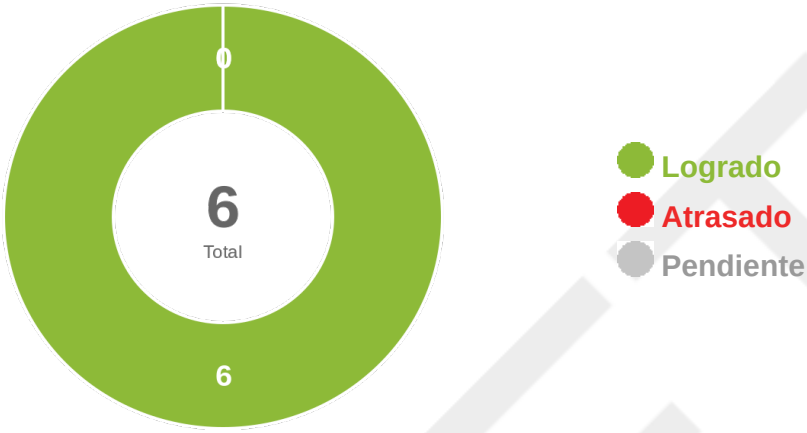
C3: Consolidación organizativa

Peso: 18% **Calificación:** Satisfactorio

66% 34%

	Indicadores	Planeado	Logrado	Estado
I1	Evaluación de objetivos y resultados obtenidos	1 (2025-05-18)	0 (2023-02-03)	
I2	Auditorías financieras	1 (2025-05-18)	1 (2022-05-01)	
I3	Minutas del plan operativo y financieroincluyendo el plan de escala autorizado por el Consejo	1 (2025-05-18)	1 (2024-09-30)	

HITOS



Hitos	Valor Logrado	Fecha Vencimiento	Fecha Lograda	Estado
*Condiciones Previas / Prior Conditions	1	2022-11-18	2022-06-30	
*Lanzamiento de campaña de adquisición de estudiantes en Linea	1	2023-05-18	2022-10-31	
*App Movil para estudiantes	1	2023-11-18	2023-05-16	

DRAFT

*Sitio Web ANA	1	2024-05-18	2023-02-28	
*Ana SaaS	1	2024-11-18	2023-02-28	
*Creación de 20 contenidos audiovisuales	20	2025-05-18	2023-06-30	

DRAFT